

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

**李宇阳(男)**

项目号 T012280193

单位 北京北方新宇信息技术有限公司

联系电话 176****2707

项目简称 北方新宇

员工号

类别 员工

卡号 0010900178551503

部门 本部41

递送地址

递送方式 统一

体检号 1822208210363



北京爱康国宾白云路门诊部有限公司 (北京白云医院)

检查日期 2022.08.21

20/3358

爱康国宾®

360° 健康全管理

爱康集团是中国领先的中高端连锁体检与健康管理集团,通过旗下多个品牌,为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老等健康管理与医疗服务。截止2022年8月,爱康集团(包括并购基金)已在59大城市设有155家体检与医疗中心。同时爱康集团与全国200多个城市超过800家医疗机构建立合作网络。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



扫码下载爱康APP

www.ikang.com

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	04
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	05
	建议与指导	
3	健康体检结果	06
	检查详细结果	
4	医学名词科普知识	13
	医学名词科普知识内容	

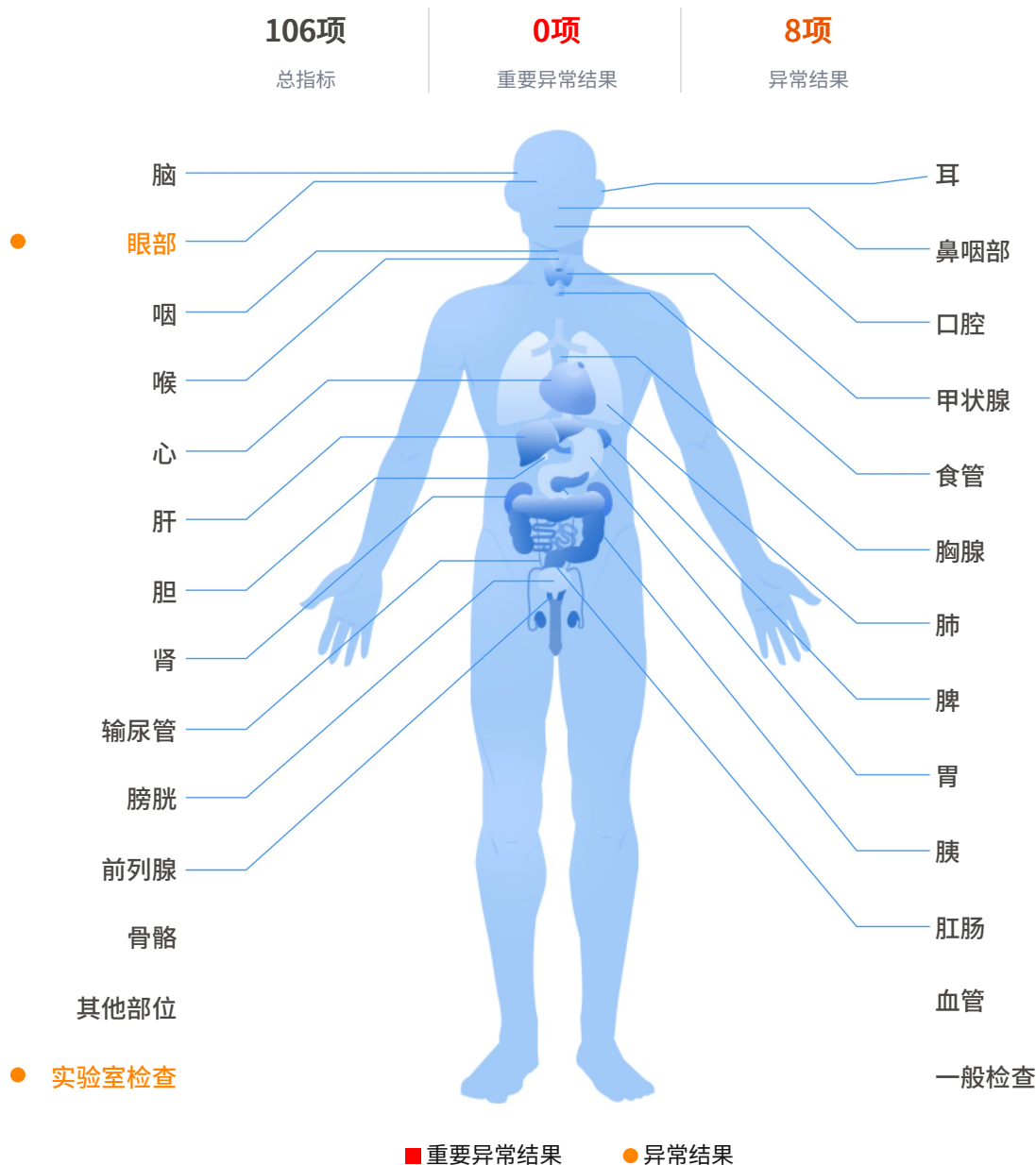
尊敬的李宇阳 先生，您好！

北京爱康国宾白云路门诊部有限公司（北京白云医院）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2022年08月21日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

【1】屈光不正

【2】胆红素异常

【3】血常规嗜酸性细胞百分比降低；嗜酸性细胞绝对值降低

【4】尿酮体阳性

【5】空腹血糖降低

【6】低密度脂蛋白胆固醇增高



下载爱康APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 屈光不正

- 1、屈光不正包括近视、远视、散光。
- 2、注意用眼卫生。
- 3、用眼时间稍长可适当闭目休息或做眼保健操和远眺。
- 4、请定期检查视力，建议到正规医疗机构验光，配戴合适的眼镜。

02 胆红素异常

- 1、直接胆红素与间接胆红素之和为总胆红素。
- 2、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素都增高，属肝细胞性黄疸；总胆红素、直接胆红素增高，属于阻塞性黄疸，如胆道结石、胆道阻塞等。总胆红素、间接胆红素增高属溶血性黄疸，如溶血性贫血、阵发性血红蛋白尿、血型不合输血等。
- 3、胆红素增高应结合肝功能、B超等结果综合分析就诊。若单纯胆红素轻度增高、其它项目正常意义不大，可动态观察。

03 血常规嗜酸性细胞百分比降低；嗜酸性细胞绝对值降低

建议动态观察，如有症状专科就诊。

04 尿酮体阳性

常见于饥饿或过食大量高脂及高蛋白食物；也可因糖尿病、肾小管功能不全、脱水等引起。

05 空腹血糖降低

生理性原因见于饥饿等，病理性因素见于胰岛素过多和特发性低血糖等，如反复发作请到医院就诊。

06 低密度脂蛋白胆固醇增高

- 1、建议戒烟（含被动吸烟）、忌酒，低脂、低糖、低胆固醇饮食，少食动物内脏，多食蔬菜瓜果类食物。
- 2、加强体育锻炼，促进脂质代谢，节制饮食，控制体重。
- 3、每3-6个月复查血脂和肝脏B超一次，复查前请低脂饮食3天。如血脂持续增高，请在医生指导下使用调脂药物。



下载爱康APP
查看彩色报告

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：周紧

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	169.0	cm		
体重	55.5	Kg		
体重指数	19.4			18.5—23.99
收缩压	116	mmHg		90.0—139.0
舒张压	70	mmHg		60.0—89.0

初步意见 未见明显异常

内科

检查者：李红武

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	90	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见 未见明显异常

外科

检查者：任晓东

检查项目	检查所见	单位
------	------	----



下载爱康APP
查看彩色报告

皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	放弃检查	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
前列腺(外科)	放弃检查	
外科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

眼科

检查者：王燕鑫、朱凯强

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)	0.3	
裸视力(左)	0.3	
矫正视力(右)		
矫正视力(左)		
色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
眼底镜检查	小瞳下眼底未见明显异常	

初步意见	屈光不正
------	------

耳鼻咽喉科

检查者：张艳军

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	

外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

血常规

操作者：袁海民 审核者：白娟

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	7.2		3.5—9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	5.10		4.3—5.8	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	153.0		130—175	g/L
红细胞比容	HCT	0.469		0.4—0.5	L/L
平均红细胞体积	MCV	92.0		82—100	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	30.0		27.0—34.0	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	326.0		316—354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.0		11—16	%
血小板计数	PLT	247.0		125—350	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	8.9		6.0—11.0	fL
血小板分布宽度	PDW	15.5		11.0—18.0	fL
淋巴细胞百分比	LYMPH%	30.4		20.0—50.0	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	64.9		40—75	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	2.2		1.1—3.2	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	4.7		1.8—6.3	10 ⁹ /L

血小板压积	PCT	0.220		0.15—0.50	%
单核细胞百分比	MONO%	4		3—10	%
单核细胞绝对值	MONO	0.29		0.1—0.6	10^9/L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	0.2	↓	0.4—8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.01	↓	0.02—0.52	10^9/L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	1		0—1	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.04		0—0.06	10^9/L

小结	1.嗜酸性细胞百分比降低 2.嗜酸性细胞绝对值降低
----	------------------------------

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者：袁海民 审核者：孙莉

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.025		1.003—1.030	
尿酸碱度	PH	6.0		4.5—8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	
尿糖	GLU	阴性		阴性	
尿酮体	KET	1+	↑	阴性	
尿胆原	URO	阴性		阴性	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	
尿隐血	BLD	阴性		阴性	

小结	尿酮体阳性
----	-------

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者：郑伏红 陈志芳 张晓丹 审核者：薛亚琴 曹文玲 康志敏

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
------	----	------	----	------	----

人纤维蛋白原降解产物(DR-70)	DR-70	5.00		0—15	ug/ml
丙氨酸氨基转移酶	ALT	13		0—50	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	17		0—40	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	16		10—60	U/L
碱性磷酸酶	ALP	70		45—125	U/L
总胆红素	TBIL	34.4	↑	0—26	umol/L
直接胆红素	DBIL	10.6	↑	0—8.5	umol/L
间接胆红素	IBIL	23.8		*	umol/L
总蛋白	TP	81.0		65—85	g/L
白蛋白	ALB	49.4		40—55	g/L
球蛋白	GLb	31.6		20—40	g/L
白蛋白/球蛋白比值	A/G	1.6		1.2—2.4	
尿素	UREA	5.00		2.78—7.85	mmol/L
肌酐	Cr	90		35—106	umol/L
尿酸	UA	334		210—420	umol/L
空腹血糖	FBG	3.76	↓	3.9—6.1	mmol/L
总胆固醇	TC	5.71		3.10—5.72	mmol/L
甘油三酯	TG	0.87		0.45—1.70	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.54		0.8—1.8	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	3.82	↑	0—3.37	mmol/L
三碘甲状腺原氨酸	T3	1.01		0.6—1.81	ng/ml
甲状腺素	T4	7.7		4.3—12.5	ug/dl
促甲状腺激素	TSH	0.976		0.38—4.34	uIU/mL

小结

- 1.直接胆红素增高
- 2.总胆红素增高
- 3.空腹血糖降低
- 4.低密度脂蛋白胆固醇增高

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者：孙先菊

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律 正常心电图	

初步意见	未见明显异常
------	--------

超声检查室

检查者：侯守春

检查项目	检查所见	单位
肝	未见明显异常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	未见明显异常	
前列腺	未见明显异常	
甲状腺	未见明显异常	

初步意见	未见明显异常
------	--------

放射科

检查者：翟慎国 审核者：翟慎国

检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。	

初步意见	未见明显异常
------	--------

主检医师：白玉霞

iKang 爱康



扫码下载爱康APP

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检

查报告

历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

■ 什么是屈光不正？



在调节松弛的状态下，正视状态的眼球（正常屈光），入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼在调节松弛的状态下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，不能把光线聚焦成清晰的图像在视网膜上，而成像于视网膜前或后，造成眼视物模糊。屈光不正包括远视、近视和散光。屈光不正的主要症状为视远和（或）视近时视物模糊。有时候，睫状肌张力过高可能引起头痛症状。偶尔，长时间注视可能导致眼表面干燥，引起眼部刺激症状、眼痒、视觉疲劳、异物感和眼红。儿童表现为阅读时皱眉和过度眨眼或者揉眼。矫治近视眼需配戴合适度数的凹透镜，使平行光线在进入眼以前发散，经眼屈光系统后聚焦于视网膜上。同理，矫治远视眼需配戴合适度数的凸透镜，矫治散光需配戴柱镜或球柱镜。散光眼即使度数很轻，若有视力下降，或出现视疲劳症状者，都应当配戴矫正眼镜。对于高度散光眼或不规则散光眼，当镜片无法矫治时可以考虑配戴硬性接触镜或行准分子激光手术治疗。

■ 什么是空腹血糖？



空腹血糖是指在隔夜空腹（至少8~10小时未进任何食物，饮水除外）后，早餐前采血所测定的血糖值，是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要的指标，是目前诊断糖尿病的主要依据，也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标。

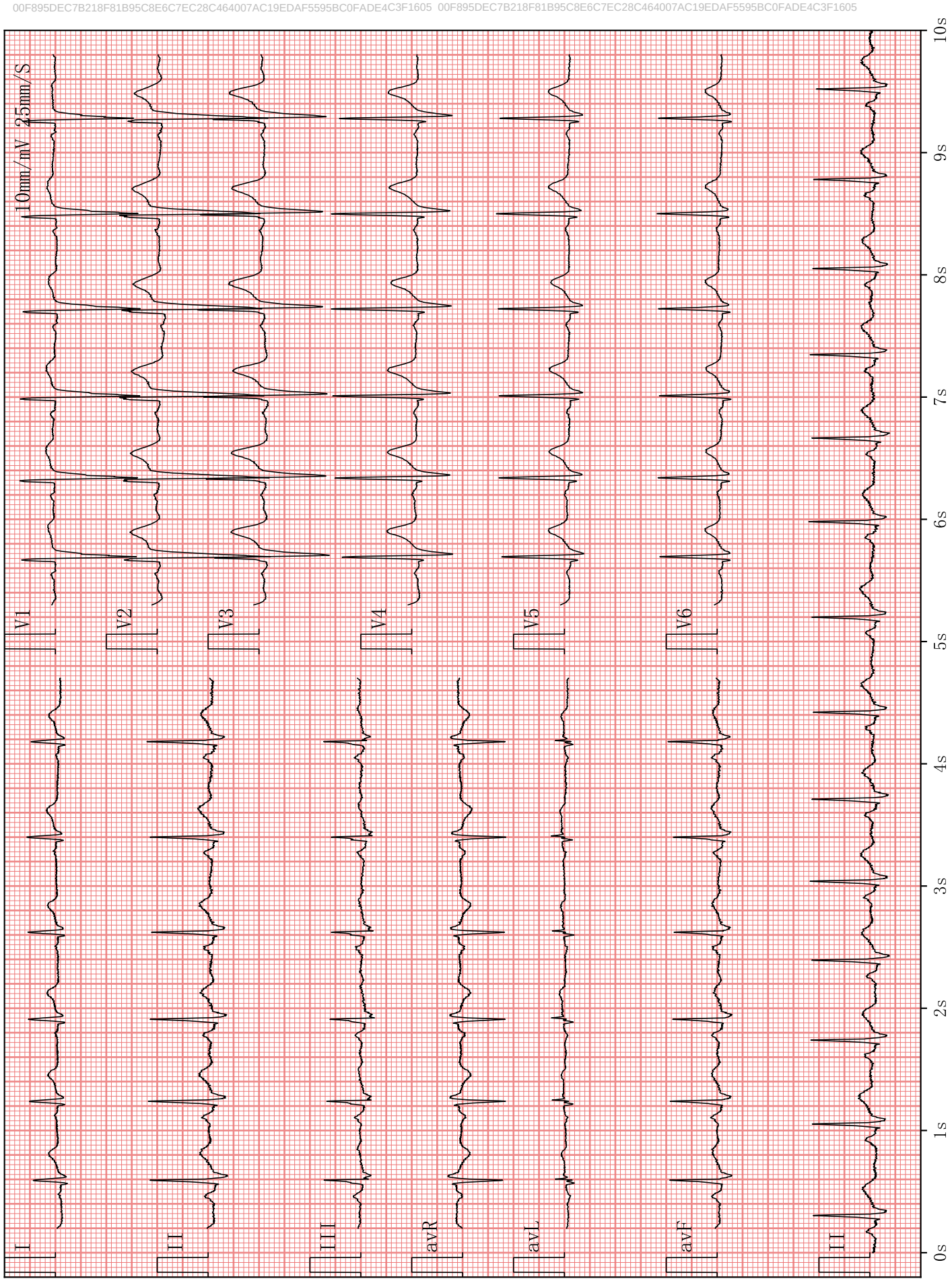


下载爱康APP
查看彩色报告

体检号:1822208210363

客户信息:李宇阳/男/20

HR:84bpm PR:0.15s QTc:411 RV5/SV1:1.58mV/1.825mV
RR:0.714s QT:0.37s R+S:3.405 P/QRS/T轴:73°/65°/45°



检查者

孙先菊